

Czym jest *zaburzenie lękowe uogólnione*

Nie „nadmierne zamartwianie”. Konkretnie zaburzenie z konkretnymi kryteriami. Diagnozuje się je u ~3 % populacji rocznie.

CZAS: 15 min · psychoedukacja 1 sesja **ŹRÓDŁO:** APA DSM-5-TR (2022); WHO ICD-11 (2022); NICE CG113

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **kryteria DSM-5 i ICD-11** (sekcja 01). Zaznacz, które rozpoznajesz u siebie (sekcja 02). Wypełnij **mapę swoich obszarów martwienia** (sekcja 03). To *nie* jest autodiagnoza — to mapa do rozmowy z terapeutą lub lekarzem. Formalna diagnoza wymaga wywiadu klinicznego.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wielu pacjentów spędza lata, myśląc, że „*po prostu są nerwowi*” albo „*mają taki charakter*”. Otrzymanie etykiety diagnostycznej działa terapeutycznie z trzech powodów: (1) **normalizuje** — 3 % populacji rocznie ma to samo, nie jesteś sam, (2) **zdejmuje wstyd** — to zaburzenie z mechanizmem, nie moralna porażka, (3) **otwiera drogę do leczenia** — istnieją skuteczne protokoły CBT, ACT, MCT, farmakoterapia. Etykieta *nie* ma stać się tożsamością („jestem GAD”) — ma stać się **punktem wyjścia do pracy**.

01



Kryteria diagnostyczne

DSM-5-TR (F41.1)

A. Nadmierny lęk i martwienie się przez **≥6 miesięcy**, dotyczące różnych obszarów (zdrowie, finanse, praca, relacje).

B. Trudność z **kontrolowaniem** martwienia.

C. Lęk wiąże się z **≥3 z 6** objawów somatycznych:

1. niepokój, „na krawędzi”
2. zmęczenie
3. trudność z koncentracją
4. drażliwość
5. napięcie mięśniowe
6. zaburzenia snu

D. Cierpienie / pogorszenie funkcjonowania.

E. Nie wynika z substancji / choroby.

F. Nie wyjaśnione lepiej przez inne zaburzenie.

ICD-11 (6B00)

Wymaga **≥3 miesięcy** objawów (krócej niż DSM-5).

Centralne cechy:

1. **uogólnione zamartwianie** o wielu codziennych sprawach (free-floating)
2. **napięcie autonomiczne** — kołatanie, suchość ust, drżenie, pocenie
3. **napięcie mięśniowe** — bóle, niepokój ruchowy
4. **nadczujność** — zaburzenia snu, drażliwość, trudność koncentracji

Objawy *nie* są ograniczone do konkretnej sytuacji (jak w SAD czy fobii).

Różnica vs DSM-5: ICD-11 mocniej akcentuje objawy somatyczne; DSM-5 — niekontrolowalność martwienia.

02 Lista samosprawdzenia — zaznacz, co rozpoznajesz u siebie

- ☐ Martwię się **codziennie**, przez większość dnia, od ≥ 6 miesięcy
- ☐ Martwię się o **wiele różnych rzeczy**, nie tylko jedną
- ☐ Łatwo się **męczę**, mimo wystarczającej ilości snu
- ☐ Jestem **drażliwy/-a**, „krótki lont”
- ☐ Mam **zaburzenia snu** — zasypianie, pobudki, niespokojny sen
- ☐ Trudno mi **zatrzymać** myślenie raz, gdy się zacznie
- ☐ Często czuję **niepokój**, „na krawędzi”, napięcie wewnętrzne
- ☐ Trudno mi **skoncentrować się**, „umysł się rozprasza”
- ☐ Mam **napięcie mięśniowe** — kark, ramiona, szczęką, plecy
- ☐ Martwienie **utrudnia mi funkcjonowanie** w pracy / relacjach

5+ zaznaczeń, w tym 2 pierwsze: warto skonsultować się ze specjalistą. To *nie* jest diagnoza — formalna diagnoza wymaga wywiadu klinicznego. Skali pomiarowe: GAD-7 (cut-off ≥ 10) i PSWQ (cut-off ≥ 45) są szybkimi przesiewami.

03 Moje obszary martwienia

#	OBSZAR / SPRAWA zdrowie / praca / finanse / dzieci / przyszłość...	JAK CZĘSTO dni/tydz.	INTENSYWNOŚĆ 0–10	LAT TRWA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kluczowe fakty: GAD dotyka ~3 % populacji rocznie, 2× częściej kobiety. Początek typowo w 20.–30. roku życia, ale może wystąpić w każdym wieku. *Skuteczne leczenie:* CBT, ACT, MCT (40–60 % pełnej remisji po 12–16 sesjach); SSRI (sertralina, escitalopram); SNRI; pregabalina. GAD *współwystępuje* z depresją (60 %), innymi zaburzeniami lękowymi (50 %), nadużywaniem substancji (25 %). Im wcześniej zaczniesz leczenie, tym **mniej ryzyko chronizacji**.